발열과 손발 피부 병변

감염성 심내막염(infective endocarditis)의 말초 징후

원인불명 발열에 손발 피부 소견이 동반되면 혈액배양과 심초음파를 고려한다. 피부의 통증·위치·출혈 양상을 구별한다.

핵심 판단의 흐름



통증과 위치로 구별하는 두 병변

병변	형태·기전
Osler 결절	손끝의 통증성 적색 구진·결절, 창백한 중심. 수일–수주 지속. 면역복합체와 관련하며 glomus body 침범이 추정된다.
Janeway 병변	손바닥·발바닥의 무통성 홍반성 반점. 패혈성 색전과 관련하며 진피의 호중구성 미세농양을 보인다.

함께 찾을 말초 소견

소견	진찰·해석
선상 출혈	Splinter hemorrhage: 손톱 아래 길쭉한 선상 출혈.
점출혈·자반	구강·결막·점막·연구개·사지에 나타날 수 있다.
원인균	교재는 포도알균·사슬알균·장알균이 약 80%를 차지하며, 황색포도알균이 가장 흔하다고 제시한다.

진료실에서 기억할 점

원인불명 발열 + 말초 피부 징후를 한 묶음으로 평가한다. 혈액배양과 심초음파를 통한 심내막염 평가로 연결한다.